EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 88294
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-10 10:55:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MONICA DEL CARMEN PISK GUTIERREZ			**RUN**	: 6.299.923-3
F.Nac	: 17-05-1953	**Edad**	: 71 AÑOS, 1 MES	**Género**	: Femenino
Dirección	: Santa Isabel			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 942081086		
Fecha Ingreso	: 2024-07-05	**Fecha Egreso**	: 2024-07-10 10:55:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DOMICILIO	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64.X-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO NO ESPECIF.COMO HEMORRAG

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

-ACV territorio ACM izquierda superficial y profundo, con TH IH-1, etiología en estudio (ATE aórtica vs cardioembolía)
-Sd febril resuelto
-Déficit B12
-Ant: HTA - Hipotiroidismo - Secuelada ACV antiguo (hemiparesia derecha, se desplaza con bastón) - mRS 2

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

BEG, HDN estable con HTA moderada en corrección progresiva, RS al monitor, eupneica, afebril hace 48h, euglicémica, tolera bien régimen mixto, logra sedestación y bipedestación con 1 operador, sin fuctuaciones ni dolor, con intención comunicativa y mejor flucencia del lenguaje.
TC cerebro s/c de control muestra infarto establecido en territorio superficial y profundo de ACM izquierda con TH IH-1.
AngioTC cerebro y cuello muestra oclusión de proción distal de M1i izquierda y placas de ateroma vulnerables en arco aórtico, estenosis de predominio cálcico origen ACI derecha aprox 70%, estenosis >50% irigen SUCA izquierda y P2 derecha.
Sin RAM por DAPT iniciada por ateromatosis aórtica posiblemente sintomática.
Exs de lab destaca ERC III estable, urocultivo(-), mantiene elevación discreta de PCR, sin leucocitosis, procalcitonina baja, HC negativo a la fecha.
Pendiente realizar ETT, Holter de ritmo se retira hoy.
Fiebre resuelta ewspontaneamente, sin correlato clínico ni de laboratorio impresiona 2° a necrosis por ACV agudo.
Se suplementó B12 IM.
Diuresis(+) dep(-)
En vista de la estabilidad clínica se decide alta a domicilio hoy, continuar DAPT por 3 meses, IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica.

PLAN DE MANEJO:

-Alta a domicilio hoy
-Continuar DAPT por 3 meses
-IC HODOM para continuar rehabilitación kinésica y fonoaudiológica
-Control en policlínico de Neurología en 15 días

INDICACIONES AL ALTA

1. -Aspirina 100 mg/día
2. -Clopidogrel 75 mg/día
3. -Atorvastatina 40 mg 2 comp/noche
4. -Levotiroxina 100 ug 1/4 comp al día 30 min antes del desayuno
5. -Famotidina 40 mg/día
6. -Amlodipino 10 mg/día
7. -Losartan 50 mg 1/2 comp al día

EXÁMENES Y RESULTADOS

10/7/24
-Crea 1 MDRD 54.66 Uremia 37
-Na 137 K 3.7 Cl 106
-PCR 14.8
-Leu 7300 Hb 11.7 Plaq 197000 Seg 72 VHS 14
-INR 0.92 TTPA 23
-Procal 0.04

9/7/24
-Crea 1.1 MDRD 48.96 Uremia 45
-CKMB 14 CK 175
-PCR 12.4
-Na 135 K 4 Cl 104
-Leu 7600 Hb 12.2 Plaq 189000 Seg 71 VHS 11
-Folato 20.7
-Procal 0.05
-Hb glic 5.4
-RPR N/R

8/7/24
-Crea 1.2 MDRD 44.29 Uremia 40
-FA 123 BI 0.8 BD 0.01 BT 0.81 GOT 39 GPT 18 GGT 11
-CK 293
-ColT 142 HDL 61 LDL 60 VLDL 21.2 TG 106
-PCR 18.5
-Na 142 K 4.3 Cl 108
-Hb 12.4 Leu 9000 Plaq 199000 Seg 72
-INR 0.97
-TSH 0.989 T4L 0.85
-B12 125 VitD 21.6

5/7/24
-Crea 1.3 MDRD 40.38 Uremia 26
-AU 5.9
-Ca 9.9
-FA 149 BI 0.75 BD 0.15 BT 0.9 GOT 22 GPT 15 GGT 11
-ColT 145 TG 99
-Na 142 K 4 Cl 106
-Hb 12.6 Leu 8500 Plaq 234000 Seg 84
-INR 0.92 TTPA 23 DD 1932
-Trop 3.9

2/7/24
-Crea 1.4 MDRD 37.07 Uremia 33
-AU 5.6
-Na 145 K 4.7 Cl 108
-OC N Urocultivo(-)

OBSERVACIONES:

Ex fco gral:
-Perfusión e hidratación N, yug no ing, rash(-)
-Cardiaco: RR 2T s/s
-Pulmonar: MP(+) SRA
-Abd: BDI, RHA(+), no palpo masas ni visceromegalia
-EE: edema(-), TVP(-), pulsos+/+

Ex neurológico:
-Mental: vigil, lenguaje muy hipofluente, y no informativo, repite mismo disilabo al interrogatorio, no comprende ordenes, no nomina, resto n/e
-PC: CV por amenaza impresiona hemianopsia derecha, pupilas medias e isocóricas, RFM D/C +/+, MOE N, PFC derecha moderada, disartria moderada, nistagmo(-), úvula y lengua centrales
-Motor: fuerza BC izq M5, ESD M2 proximal y M0 distal, EID M2, RCP extensor derecho, espasticidad BC derecha moderada
-Sensitivo: impresiona hipoalgesia BC derecha leve mayor a braquial
-Cerebelo: n/e
-Signos meningeos(-)

Saulo Venegas Figueroa
MEDICO TRATANTE
16138950-1

JEFE SERVICIO